Bronquiolite Viral Aguda
Guia de estudo – Semiologia e Semiotécnica

Fabricia, Letícia e Celma · Seminário Interdisciplinar – Turma 61 · 12/11/2026

1. Sua parte na apresentação

- Slides 9 a 15. Tempo-alvo do trio: cerca de 6 a 7 minutos (é a maior parte do seminário).
- **Fabricia** – slides 9 e 10: sinais e sintomas e sinais de alarme.
- **Letícia** – slides 11 e 12: diagnóstico e tratamento.
- **Celma** – slides 13, 14 e 15: cuidados de enfermagem (I e II) e anotação de enfermagem.
- Abertura (capa) e conclusão: a definir pela equipe.

2. Contexto: por que esta parte importa

A orientação pede, em Semiologia e Semiotécnica: sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento, cuidados de enfermagem com o paciente hospitalizado e uma anotação de enfermagem. É a parte mais prática do seminário e a que mais tem cara de "técnico de enfermagem": a banca vai querer ver que vocês sabem reconhecer, agir e registrar.

A sequência conta uma história: a Fabricia mostra **o que o bebê apresenta** (e quando é grave); a Letícia mostra **como o médico confirma e o que é indicado ou não**; a Celma mostra **como a enfermagem coloca isso em prática ao lado do bebê e registra**.

Tratamento × cuidado de enfermagem: o tratamento responde "o que se usa e por quê" (decisão médica, com base na diretriz da SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria). O cuidado de enfermagem responde "como fazer, vigiar e registrar" (verbos de ação: verificar, instalar, pesar, posicionar, registrar, comunicar, orientar).

3. Sugestão de falas

As falas são um roteiro: não precisam ser decoradas palavra por palavra. Entenda a ideia e fale com as próprias palavras, olhando para a banca.

Fabricia – Slide 9: Sinais e sintomas · *≈ 1 minuto*

"A bronquiolite começa como um resfriado: nos primeiros dias o bebê tem coriza, nariz entupido, às vezes febre baixa, e tosse."

"Entre o terceiro e o quinto dia ela costuma piorar: a tosse aumenta, aparece o chiado, a respiração fica rápida e superficial e o bebê tem dificuldade para mamar."

Fabricia – Slide 10: Sinais de alarme · *≈ 1 minuto*

"Estes são os sinais que indicam gravidade: frequência respiratória acima de 60 ou saturação abaixo de 92%, tiragem, gemido e batimento de asa de nariz, lábios ou

unhas arroxeados, pausas na respiração, recusa alimentar ou fralda seca por 12 horas, e sonolência."

"Qualquer um desses sinais, a enfermagem comunica imediatamente. A Letícia vai explicar agora como se faz o diagnóstico e o tratamento."

Letícia – Slide 11: Diagnóstico · *≈ 1 minuto*

"O diagnóstico da bronquiolite é clínico: feito pela história e pelo exame físico. Não existe um exame que, sozinho, confirme a doença."

"A oximetria de pulso mede a saturação, o painel viral pode ser feito nos internados para organizar o isolamento, e raio-X e exames de sangue não são de rotina: só se houver dúvida ou suspeita de complicação."

Letícia – Slide 12: Tratamento · *≈ 1 minuto e meio*

"Não existe remédio contra o vírus: o tratamento é de suporte. O que é indicado: manter a hidratação, com amamentação e líquidos, e por sonda ou pela veia se o bebê não aceitar; lavagem nasal com soro antes das mamadas; oxigênio no hospital se a saturação ficar abaixo de 90 a 92%; e antitérmico se houver febre."

"Em casa, nenhum remédio sem receita, e voltar ao serviço se aparecer sinal de alarme."

"E tão importante quanto: o que NÃO é indicado, segundo a SBP. Broncodilatador, porque o problema é muco e edema e não o músculo; corticoide, sem benefício nos estudos; antibiótico, porque a doença é viral; e vaporizador ou umidificador, sem evidência de benefício."

"O tratamento diz o que o bebê precisa. Agora a Celma mostra como a enfermagem garante isso ao lado dele."

Celma – Slides 13 e 14: Cuidados de enfermagem · *≈ 2 minutos*

"Primeiro, monitorizar: contar a frequência respiratória por 1 minuto inteiro, verificar saturação, frequência cardíaca e temperatura, observar tiragem e gemência."

"Oxigênio: instalar conforme a prescrição, checar a adaptação do cateter e a umidificação, e conferir a saturação depois. Vias aéreas: higiene nasal com soro antes das mamadas, aspiração suave e superficial só quando necessária, e registrar o aspecto da secreção."

"Hidratação: oferecer as mamadas em volumes menores e mais vezes e pesar as fraldas. Conforto e proteção: cabeceira a 30 graus, agrupar os cuidados para o bebê descansar, precaução de contato e gotículas e higiene das mãos."

"E comunicar e orientar: avisar a enfermeira na hora se piorar e ensinar a mãe a lavar o nariz, oferecer líquidos e reconhecer os sinais de alarme."

Celma – Slide 15: Anotação de enfermagem · *≈ 1 minuto*

"Para fechar, um exemplo de anotação de enfermagem do Miguel, um bebê de 5 meses internado com bronquiolite." (ler os trechos principais: estado geral, sinais vitais, procedimentos, orientação e comunicação)

"Repare que a anotação tem data e hora, descreve o que foi observado e o que foi feito, e termina com nome e COREN. Agora a Bianca vai mostrar os dados de Minas e de Montes Claros."

4. Conteúdo para estudar

Fabricia – Sinais e sintomas

- Fase inicial (1 a 3 dias): coriza, congestão nasal, febre baixa (nem sempre), tosse.
- Fase de piora (3 a 5 dias): tosse intensa, sibilância (chiado), taquipneia (respiração rápida), esforço respiratório, dificuldade para mamar, irritabilidade.
- Melhora: geralmente em 7 a 10 dias; a tosse pode durar mais.
- Sinal × sintoma: sinal é o que a equipe observa (tiragem, cianose, FR alta); sintoma é o que é relatado (falta de apetite, mal-estar).

Fabricia – Sinais de alarme / critérios de internação (SBP, 2017)

- Apneia (pausas na respiração).
- Piora do estado geral: hipoativo, prostrado, acorda só com estímulo prolongado.
- Desconforto respiratório: gemência, retração torácica (tiragem), FR (frequência respiratória) acima de 60, cianose central, SpO_2 (saturação) abaixo de 92% persistente.
- Sinais de desidratação; recusa alimentar ou ausência de diurese por 12 horas.
- Comorbidades: displasia broncopulmonar, cardiopatia, imunodeficiência, doença neuromuscular.

Letícia – Diagnóstico

O diagnóstico é principalmente clínico (SBP, 2017): história (idade, início com resfriado, contato com gripados, época do ano) e exame físico (FR por 1 minuto, tiragem, ausculta com sibilos e crepitações, estado geral).

Exame	Uso na bronquiolite
Oximetria de pulso	Mede a SpO_2. Uso intermitente nos internados; o uso contínuo de rotina foi associado a internações mais longas (SBP).
Painel viral	Não muda o tratamento, mas ajuda o hospital a organizar o isolamento dos pacientes.
Raio-X de tórax	Não é rotina; só em dúvida diagnóstica ou suspeita de complicação (AAP, 2014).
Exames de sangue	Não são rotina; considerados em casos graves ou suspeita de infecção bacteriana.

Letícia – Tratamento (como está no slide 12)

Princípio: não há medicamento que abrevie a doença; o tratamento é de suporte (SBP, 2017).

INDICADO ✓	Por quê / quando
Hidratação	Manter amamentação e líquidos; se não aceitar, sonda nasogástrica ou soro na veia (solução isotônica).
Lavagem nasal com SF 0,9%	O bebê respira pelo nariz; a lavagem melhora a respiração e a mamada.
Oxigênio (hospital)	Se SpO_2 abaixo de 90–92%. Acima de 90% sem acidose, a SBP não recomenda.
Antitérmico	Se houver febre, conforme prescrição.
Em casa	Nenhum remédio sem receita; voltar ao serviço se houver sinal de alarme.

NÃO INDICADO ×	Motivo (SBP, 2017)
Broncodilatador (ex.: salbutamol) e adrenalina	Sem melhora nos estudos; a obstrução é por muco e edema, não por contração do músculo como na asma.
Corticoide	Ensaios grandes e multicêntricos sem benefício.
Antibiótico	A doença é viral; só se houver infecção bacteriana associada.
Vaporizador / umidificador (névoa)	"Sem evidência de recomendação" (SBP, tabela de condutas).

Sobre nebulização: a nebulização é só a forma de administrar. Nebulizar broncodilatador ou adrenalina não é recomendado; a salina hipertônica 3% (SSH 3%) pode ser considerada no hospital, por decisão médica; o soro comum 0,9% nebulizado não tem recomendação.

Celma – Cuidados de enfermagem

- Monitorizar: FR por 1 minuto, SpO_2, FC, temperatura, tiragem, gemência; registrar com horário.
- Oxigênio: instalar conforme prescrição; checar adaptação do cateter e umidificação; conferir a SpO_2 depois.
- Vias aéreas: higiene nasal com SF 0,9% antes das mamadas; aspiração suave e superficial só se necessária; registrar aspecto e quantidade da secreção.
- Hidratação: mamadas em volumes menores e mais vezes; pesar fraldas (1 g ≈ 1 mL de urina); registrar aceitação e vômitos.
- Conforto e proteção: cabeceira a 30°; agrupar cuidados; precaução de contato e gotículas; higiene das mãos nos 5 momentos.

- Comunicar e orientar: avisar a enfermeira na hora se piorar; ensinar a mãe a lavar o nariz, oferecer líquidos e reconhecer sinais de alarme.

Celma – Anotação de enfermagem

A anotação é o registro escrito, feito pelo técnico ou auxiliar, de tudo o que foi observado e realizado. É documento legal: garante a continuidade do cuidado e protege o profissional. A evolução de enfermagem é diferente: é privativa do enfermeiro e envolve análise e julgamento clínico.

- Sempre com data e hora; linguagem objetiva; sem rasuras (se errar, escrever "digo" e corrigir); sem linhas em branco.
- Registrar o que viu, o que fez e o resultado.
- Terminar com nome, categoria e COREN (Conselho Regional de Enfermagem).
- Usar "com diagnóstico médico de..." em vez de dar diagnóstico próprio.

5. O que revisar antes do seminário

- ☐ Fabricia: listar de memória 6 sinais de alarme com os valores (FR acima de 60, SpO_2 abaixo de 92%).
- ☐ Letícia: explicar por que o diagnóstico é clínico e quando pedir raio-X; saber 4 itens indicados e 4 não indicados, com o motivo.
- ☐ Celma: ler a anotação em voz alta sem tropeçar nas siglas (SSVV, FC, FR, SpO_2, irpm, bpm); explicar como pesar fralda.
- ☐ Todas: saber explicar a diferença entre tratamento (o que/por quê) e cuidado de enfermagem (como).
- ☐ Todas: saber o que é a SBP e por que é a nossa referência.

6. Perguntas que a banca pode fazer

P: Por que não se usa corticoide?

R: Porque estudos grandes não mostraram benefício: não reduz internação nem tempo de doença. Por isso a SBP não recomenda.

P: E o broncodilatador?

R: Também não. Na bronquiolite a obstrução vem de edema, muco e restos celulares, e não de contração do músculo como na asma.

P: A nebulização ajuda?

R: Depende do que se nebuliza. Nebulizar broncodilatador ou adrenalina não é recomendado; vaporizador/umidificador (névoa) também não. A salina hipertônica 3% pode ser considerada no hospital, por decisão médica.

P: Qual a diferença entre tratamento e cuidado de enfermagem?

R: O tratamento diz o que o bebê precisa e é definido pelo médico com base na diretriz. O cuidado de enfermagem é como a equipe executa, vigia e registra isso ao lado do bebê.

P: Quando o bebê precisa de oxigênio?

R: Quando a saturação fica abaixo de 90 a 92%, conforme prescrição. O técnico instala e monitora, mas não decide sozinho.

P: Por que o Miguel não está no oxigênio?

R: Porque a saturação dele é de 93% em ar ambiente, acima do ponto em que a diretriz indica O_2. Mas ele precisa de monitorização, pois pode piorar entre o 3º e o 5º dia.

P: Qual a diferença entre anotação e evolução de enfermagem?

R: A anotação é feita pelo técnico/auxiliar e registra o que foi observado e realizado. A evolução é privativa do enfermeiro e inclui análise e julgamento clínico.

7. Pegadinhas e erros a evitar

- Não dizer que "nebulização" em geral é proibida: o não recomendado é nebulizar broncodilatador/adrenalina e usar vaporizador (névoa).
- Não dizer que o técnico decide o oxigênio: ele instala conforme prescrição.
- Não esquecer "comunicado à enfermeira" na anotação.
- Não misturar tratamento e cuidado: tratamento = o quê; cuidado = como.

8. Glossário de siglas

Siglas que aparecem na apresentação e nos documentos. As mais importantes para a sua parte estão em destaque na seção 4; aqui está a lista completa para toda a equipe.

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
VSR	Vírus Sincicial Respiratório	Principal vírus causador da bronquiolite (até 75% dos casos).
BVA	Bronquiolite Viral Aguda	Nome completo da doença.
SBP	Sociedade Brasileira de Pediatria	Entidade científica que reúne os pediatras do Brasil. Publica diretrizes, que são guias feitos a partir da análise de estudos científicos, para orientar médicos e equipes no diagnóstico e no tratamento. É a principal referência do trabalho: tudo o que dizemos sobre diagnóstico, tratamento, "indicado" e "não indicado" vem da diretriz da SBP de 2017.
AAP	American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria)	Equivalente americana da SBP. A diretriz de bronquiolite da AAP (2014) é usada no mundo todo e foi base para a diretriz brasileira.
SUS	Sistema Único de Saúde	Sistema público de saúde do Brasil.
SES-MG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Gestão da saúde no estado. Compra e distribui vacinas e imunobiológicos para as regionais, acompanha os casos de SRAG e publica os dados de VSR do estado.
SRS	Superintendência Regional de Saúde (de	"Braço" da SES-MG no Norte de Minas. Coordena 54 municípios: recebe as

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
	Montes Claros)	vacinas do estado e repassa para as cidades e maternidades.
SMS	Secretaria Municipal de Saúde (de Montes Claros)	Gestão da saúde na cidade: postos, hospitais conveniados, vigilância. É a autora do Relatório Anual de Gestão.
RAG	Relatório Anual de Gestão	Prestação de contas anual da SMS: mostra dados de saúde da cidade e se as metas foram cumpridas. Precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
CMS	Conselho Municipal de Saúde	Grupo formado por usuários, trabalhadores, prestadores e governo que fiscaliza a saúde do município. Aprovou o RAG 2025 em 25/02/2026.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS	Órgão do Ministério da Saúde que guarda os bancos de dados oficiais do SUS (internações, óbitos, nascimentos).
TabNet	Ferramenta de tabulação do DATASUS	Site onde qualquer pessoa monta tabelas com os dados do SUS, escolhendo ano, local, idade e doença.
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	Banco que registra todas as internações pagas pelo SUS. De onde vêm os números de internação da apresentação.
AIH	Autorização de Internação Hospitalar	Documento que o hospital preenche para o SUS pagar a internação. Cada AIH conta como uma internação no SIH.
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão	Código padronizado de cada doença. J20 = bronquite aguda; J21 = bronquiolite aguda.
SRAG	Síndrome Respiratória Aguda Grave	Quadro respiratório grave que leva à internação (febre, tosse, falta de ar, saturação baixa). Toda SRAG internada deve ser notificada, no SUS e na rede particular.
SIVEP-Gripe	Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe	Sistema onde os hospitais (públicos e particulares) notificam os casos de SRAG e o vírus encontrado no exame.
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz	Instituição de pesquisa do Ministério da Saúde.
InfoGripe	Boletim da Fiocruz	Analisa os dados do SIVEP-Gripe e mostra se os casos de SRAG estão subindo ou caindo em cada estado.
Unidade Sentinela	Serviço de vigilância de síndrome gripal	Unidade que coleta amostras de pacientes com síndrome gripal e envia

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
		para análise, para saber quais vírus estão circulando (VSR, influenza, COVID-19).
PNI	Programa Nacional de Imunizações	Programa do Ministério da Saúde que define o calendário de vacinas do SUS.
SI-PNI	Sistema de Informação do PNI	Sistema onde são registradas as doses aplicadas. É ali que se vê a cobertura vacinal (porcentagem do público vacinado).
CRIE	Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais	Serviço do SUS que aplica vacinas e imunobiológicos especiais, que não ficam nos postos comuns, para grupos específicos (prematuros, cardiopatas, imunossuprimidos). Na regional de Montes Claros, recebeu 503 das 766 doses de nirsevimabe, para atender crianças de risco que já saíram da maternidade.
Conitec	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS	Comissão que avalia se um remédio ou vacina deve entrar no SUS. Recomendou o nirsevimabe e a vacina VSR para gestantes em 2025.
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Órgão que autoriza o registro de remédios e vacinas no Brasil.
Nirsevimabe	Anticorpo monoclonal contra o VSR	Anticorpo “pronto”, aplicado em dose única no bebê de risco (imunização passiva). Não é vacina.
UTI	Unidade de Terapia Intensiva	Setor para pacientes graves.
PS	Pronto-Socorro	Atendimento de urgência.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Luvas, avental, máscara, óculos.
SSVV	Sinais vitais	Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e pressão arterial.
T	Temperatura (axilar)	—
FC / bpm	Frequência cardíaca / batimentos por minuto	—
FR / irpm	Frequência respiratória / incursões respiratórias por minuto	—
SpO_2	Saturação periférica de oxigênio	Medida pelo oxímetro de pulso. Abaixo de 92% persistente é sinal de alarme.

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
PA	Pressão arterial	—
O_2 / CO_2	Oxigênio / gás carbônico	—
SF 0,9%	Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%)	Usado na lavagem nasal.
SSH 3%	Solução salina hipertônica a 3%	Soro mais concentrado; pode ser nebulizado no hospital, por decisão médica.
COREN-MG	Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais	Órgão que registra e fiscaliza os profissionais de enfermagem. O número do COREN vai na assinatura da anotação.
IA	Inteligência artificial	—

9. Fontes desta parte

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – 2017**. Rio de Janeiro: SBP, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20277e-Diretrizes_VSR.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

RALSTON, S. L. *et al*. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. **Pediatrics**, Itasca, v. 134, n. 5, p. e1474-e1502, nov. 2014. DOI: 10.1542/peds.2014-2742.

10. Dicas gerais da equipe

- Divisão da equipe: Graziele e Gabriel (Microbiologia, slides 2 a 5); Fernanda e Dayane (Anatomia, slides 6 a 8); Fabricia (sinais e sintomas e sinais de alarme, slides 9 e 10); Letícia (diagnóstico e tratamento, slides 11 e 12); Celma (cuidados e anotação de enfermagem, slides 13 a 15); Bianca (dados e vacinação, slides 16 a 18). Abertura (slide 1) e conclusão (slide 19): a definir.
- Tempo total: 15 a 20 minutos. Cronometrem pelo menos um ensaio completo com todos (reunião de segunda-feira).
- A orientação exige que todos saibam todas as partes: se alguém faltar, a equipe assume. Leiam também o resumo das outras disciplinas e o glossário de siglas.
- Não leiam o slide. O slide mostra o dado; a fala explica o porquê.
- Se não souber uma resposta, não invente: diga que a equipe pode complementar e passe para quem domina aquela parte.
- Sempre que falar uma sigla pela primeira vez, diga o nome completo (ex.: “a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria”).
- Slides devem chegar à líder de turma até domingo (08/11); prazo final com a professora: 10/11.